

Depresión

TCC — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

El Trastorno Depresivo Mayor se caracteriza por estado de ánimo deprimido y/o anhedonia persistente durante al menos dos semanas, acompañados de alteraciones cognitivas, somáticas y conductuales que deterioran el funcionamiento. Prevalencia estimada: 5-8% de la población adulta. Alta comorbilidad con ansiedad, abuso de sustancias y trastornos de personalidad.

MODELO COGNITIVO (BECK)

La **tríada cognitiva negativa** es el núcleo del modelo: visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro. Las creencias nucleares ("soy un fracaso", "no merezco amor") alimentan distorsiones cognitivas como filtro negativo, catastrofización y personalización, que mantienen el ciclo depresivo.

TÉCNICAS E INTERVENCIONES TCC — PASO A PASO

1	Psicoeducación del modelo cognitivo Presentar la tríada cognitiva con ejemplos del propio paciente. Usar el diagrama de pensamiento-emoción-conducta. Validar que los pensamientos no son hechos.
2	Activación conductual Registrar actividades diarias con nivel de placer y dominio (0-10). Identificar actividades evitadas. Programar actividades gradualmente comenzando por las más accesibles. Evaluar predicción vs. resultado.
3	Registro ABC Situación → Pensamiento automático → Emoción → Conducta. Enseñar primero C (consecuencia) para luego trabajar en B (creencia). Practicar en sesión con situaciones recientes.
4	Reestructuración cognitiva Identificar pensamiento automático → Examinar evidencia a favor y en contra → Identificar distorsión → Generar pensamiento alternativo equilibrado → Evaluar cambio emocional.
5	Experimentos conductuales Diseñar pruebas de realidad para testear creencias. Ej: si cree que nadie quiere estar con él, programar una salida y registrar el resultado. Revisar en siguiente sesión.
6	Trabajo con creencias nucleares (fase avanzada) Técnica de la flecha descendente para identificar creencia nuclear. Trabajo con el continuo cognitivo. Tarjeta de creencias nuevas con evidencia acumulada.
7	Prevención de recaídas Identificar señales de alerta tempranas. Plan de acción personalizado. Revisión de herramientas aprendidas. Espaciar sesiones gradualmente y evaluar autonomía.

Depresión

TCC — Ficha clínica

CUÁNDO USARLA / INDICACIONES

- Episodio depresivo mayor leve a moderado (primera línea).
- En depresión severa, combinar con tratamiento farmacológico.
- Distimia y depresión persistente: foco en activación y creencias nucleares.
- Depresión con alta rumiación: considerar añadir componentes de mindfulness (MBCT).

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	Foco en áreas laboral, relacional y de rol. Trabajar esquemas vinculados a rendimiento y valía. La activación conductual puede incluir objetivos vitales significativos.
Adolescentes	Priorizar activación conductual antes que reestructuración. Incluir pares y entorno escolar en la formulación. Lenguaje más directo y menos introspectivo. Involucrar a la familia en psicoeducación.
Niños (8-12 años)	Usar metáforas concretas ("el termómetro del ánimo"). Actividades con dibujo o juego. Enfatizar acciones. Trabajar siempre con cuidadores.

Clave clínica: La activación conductual debe preceder a la reestructuración cognitiva en pacientes con alta inhibición.